

Un adulto autista mayor que apoyas en casa

Para trabajadores de cuidado a domicilio, asistentes personales y personal de apoyo comunitario — apoyar a un adulto autista mayor (aproximadamente 60 años o más).

la idea principal

El autismo, a través del **monotropismo**, significa que la atención de un adulto mayor siempre se ha concentrado en unos pocos «túneles» profundos e intensos. Muchos adultos autistas mayores nunca fueron identificados y cargan con una vida de camuflaje y necesidades no satisfechas. Sus visitas pueden ser la relación más predecible y aceptante de su semana. Proteja las rutinas, los intereses y los objetos de toda la vida; reduzca la carga sensorial; comunique literalmente; y vigile el burnout y la dolor que el hecho de «no quejarse» puede ocultar.

Lo que puede observar — y lo que realmente está sucediendo

Puede observar...	Lo que suele suceder
Misma rutina, mismos objetos, mismos intereses — cada visita	La previsibilidad y el flujo son regulación e identidad
Evita los cuidados, cancela, «no le gusta que vengas»	Experiencias negativas de toda la vida + barreras sensoriales/de comunicación
Respuestas lentas, inusuales; parece confundido	A menudo es tiempo de procesamiento + diferencia autística — no necesariamente demencia
No reporta la dolor o los síntomas	Diferencias de intérocepción ; «no quejarse» ≠ «no sufrir»
Retraído, agotado	Posiblemente décadas de burnout acumulada

Intente esto

- **Sea la presencia predecible y aceptante** — misma persona, misma hora, mismo plan; avise antes de cualquier cambio.
- **Proteja las rutinas, los intereses y los objetos de toda la vida** — eliminarlos «por seguridad» puede causar un daño real.
- **Comunique de forma clara, literal y lenta**, por escrito cuando ayude; deje un tiempo de procesamiento suficiente.
- **Reduzca la carga sensorial** y tenga en cuenta los cambios de audición o visión que agravan las diferencias crónicas.
- **Pregunte proactivamente sobre la dolor y los síntomas** — no espere a que ellos lo mencionen.

Evite esto

- Perturbar las rutinas o eliminar objetos familiares.
- Suponer que la lentitud o un estilo diferente significa declive cognitivo — evalúe, no suponga.
- Assimilar el silencio o una apariencia «estable» con estar «bien».

Vigile el **burnout autístico** (a menudo el fruto de varias décadas) y el **aislamiento social** (un riesgo mayor). La pregunta **¿demencia o diferencia?** es difícil y está poco investigada — señale los cambios con apoyo y busque una evaluación informada sobre el autismo en lugar de suponer. Reporte cualquier nueva angustia como un posible señal de alarma médica.

If the person is a woman

Las mujeres autistas mayores son un grupo especialmente sub-identificado, habiendo camuflador durante toda su vida; un historial de «ansiedad» o burnout junto con una diferencia crónica justifica una consideración seria del autismo.

Acerca de esta guía

Asistida por IA, derivada de los borradores de investigación del proyecto — la **Guía para la familia** (Parte 5), el **Guide pour les praticiens et les soins de santé** (Partie 3.5) y la brève sobre el **Monotropismo**. Utiliza el lenguaje de identidad primero. **Informativo — no es un herramienta de diagnóstico.** La evidencia sobre el autismo en la vejez es escasa; adáptelo al individuo.

Fuentes clave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Klein et al. (2024, aging & autism); Raymaker et al. (2020); Kelly Mahler (2024); OAR (aging on the spectrum). Las citas completas están en los borradores fuente.